

②

分子標的治療薬

標的分子から読み解く薬剤分類と副作用

1 主な薬剤分類と代表薬

EGFR阻害薬	ゲフィチニブ・オシメルチニブ(TKI)、セツキシマブ(抗体薬) — EGFR経路を阻害
HER2阻害薬	トラスツズマブ、ペルツズマブ、T-DXd(抗体薬物複合体) — HER2受容体を標的
血管新生阻害薬	ベバシズマブ(抗体薬)、レンバチニブ・スニチニブ(TKI) — 腫瘍血管新生(VEGF経路)を阻害
BCR-ABL阻害薬	イマチニブ、ダサチニブ — 慢性骨髄性白血病の異常チロシンキナーゼを阻害
mTOR阻害薬	エベロリムス — 細胞増殖シグナル伝達経路(PI3K/AKT/mTOR)を阻害

2 標的分子に応じた特徴的な副作用



血管新生阻害薬:高血圧、蛋白尿、出血傾向、創傷治癒遅延



EGFR阻害薬:ざ瘡様皮疹、爪囲炎、下痢



HER2阻害薬:心機能低下(可逆性の高いType II心毒性)



mTOR阻害薬:口内炎、高血糖、間質性肺疾患

3 分子標的薬に特有の注意点

- ☐ 経口TKIの多くはCYP3A4で代謝され、アゾール系抗真菌薬・グレープフルーツ等との相互作用に注意する
- ☐ 血管新生阻害薬は創傷治癒遅延のため、手術前後で休薬期間の設定が必要
- ☐ HER2阻害薬は治療開始前・治療中の定期的な心機能評価(LVEF)が必須
- ☐ 間質性肺疾患は複数の分子標的薬に共通するリスクで、乾性咳嗽・呼吸困難に注意する

分子標的薬の副作用は「標的分子が正常組織でも働いている」ことの反映であることが多く、作用機序の理解が副作用予測の近道になる。

がん薬物療法 研修シリーズ — 基礎知識(深掘り)② 分子標的治療薬 — NCCNガイドライン、CTCAE v5.0に基づく